

Daję radę — *i się wykańczam*

Latami kompensowałeś/-aś deficyty wysiłkiem 2× większym. Funkcjonujesz — ale za jaką cenę. To maskowanie.

CZAS: 25 min refleksji Po późnej diagnozie + przy wypaleniu

ŹRÓDŁO: Hinshaw (2002, 2018); Young i wsp. (2020); Młynarski-Liebel i wsp. (2023)

JAK UŻYWAĆ

Rozpoznaj **swoje strategie maskowania** — perfekcjonizm kompensacyjny, hiperpracowitość, ukrywanie zapominalstwa, udawanie skupienia. Wprowadź **selektywne zdejmowanie maski**: w bezpiecznych przestrzeniach (terapia, bliskie relacje, grupy ADHD) pokazujesz swoją prawdziwą prezentację. Stopniowo. Bez ryzyka. To **proces miesięcy/lat**, nie tygodni.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Maskowanie (ang. *masking*) w ADHD to **zestaw strategii kompensacyjnych**, którymi niediagnozowana lub późno diagnozowana osoba ukrywa lub nadrabia trudności — przez cały dzień. Hinshaw (2002), Young i wsp. (2020): **typowo silne** u kobiet, osób z wysokim IQ, perfekcjonistek/-ów i osób z domu o wysokich wymaganiach. Młynarski-Liebel i wsp. (2023): 79% kobiet z ADHD diagnozowanych w dorosłości raportuje wieloletnie maskowanie. **Koszt:** chroniczne wyczerpanie, wypalenie, lęk, depresja wtórna, niska samoocena („*udaję dorosłego, a wewnątrz jestem dzieckiem, które nie potrafi*”). **Maskowanie samo w sobie nie jest złe** — to **adaptacyjna strategia**. Problem powstaje, gdy **nie da się odpocząć**.

01 ? Pięć typowych strategii maskowania

1 · PERFEKCJONIZM KOMPENSACYJNY

„Jeśli sprawdzę 10 razy, na pewno niczego nie zapomnę”. **Każde zadanie 3× więcej czasu** niż wymaga. Bezpiecznik przed krytyką — drogi w energii.

2 · HIPERPRACOWITOŚĆ

„Inni robią X w 2 godziny, ja w 6 — ale i tak robię”. **Praca w godzinach, których inni mają wolne**. „Dam radę” za cenę weekendów i snu.

3 · UKRYWANIE ZAPOMINALSTWA

Listy *tajne*, alarmy bez wiedzy innych, „*przepraszam, się pomyliłem/-am*” zamiast „*zapomniałem/-am*”. **Energetycznie kosztowna fasada**.

4 · TŁUMIENIE CIAŁA

„Nie poruszam się, bo to wygląda dziwnie”. **Wewnętrzny niepokój**, zewnętrzny spokój. Kręjące się mięśnie, zaciśnięte zęby. Po pracy — wybuch.

5 · UDAWANIE SKUPIENIA

W spotkaniach — kontakt wzrokowy, kiwanie głową, „*tak, rozumiem*”. Wewnątrz: **nie słyszysz** dawno. Później musisz pytać kolegów/-żanki, „*co właściwie ustaliliśmy?*” — albo udajesz, że pamiętasz.

02 ✗ Cztery koszty wieloletniego maskowania

Chroniczne wyczerpanie. Nie zwykłe zmęczenie — wyczerpanie głębokie. „*Nie mam siły na nic poza pracą*”. Weekendy w łóżku.

Wypalenie. W którymś momencie maska się rozpada. Często 30–40 r.ż. Często po dziecku/awansie. „*Dawałem/-am radę, teraz nie*”.

Lęk i depresja wtórna. Lęk przed tym, że ktoś zobaczy „*prawdziwą*” wersję. Depresja po wieloletnim wysiłku bez nagrody.

Niska samoocena. „*Udaję dorosłego, a wewnątrz jestem dzieckiem, które nie potrafi*”. Tożsamość rozszczepiona na fasadę i ukrytą prawdę.

03 Twoja mapa maskowania

Nazwij swoje strategie. Po nazwaniu można zacząć selektywnie zdejmować maskę — tam, gdzie bezpiecznie.

CO MASKUJĘ W PRACY

— konkretne strategie

CO MASKUJĘ W RODZINIE

— przed partnerem, rodzicami

ILE ENERGII MNIE TO KOSZTUJE

— skala 1–10, codziennie

CO SIĘ DZIEJE, GDY NIE MOGĘ UTRZYMAĆ MASKI

— wieczorem, w weekend

04 Selektywne zdejmowanie maski — gdzie bezpiecznie

U TERAPEUTY/-TKI

Pierwsze miejsce. **Płatna usługa** w bezpiecznej przestrzeni. Możesz mówić bez konsekwencji. *Trening*, zanim pokażesz się bliskim.

W GRUPIE ADHD

„O, tak — też tak miałem/-am!”. Grupy społecznościowe lub terapeutyczne dla osób z ADHD. **Rozumieję bez tłumaczenia.**

U BLISKIEJ OSOBY

Jeden/-na partner/-ka, przyjaciel/-ółka, rodzeństwo. **Stopniowo**, przez konkretne przykłady. „*Wiesz, naprawdę o tym zapomniałem/-am — to nie wymówka*”.

W DOMU SAM/-A

Pozwól sobie nie maskować *fizycznie* — kręć się, mów do siebie, używaj list nieukrywanych. **Dom jako strefa bez fasady.**

Czego nie rób od razu: nie zdejmuj maski w pracy ani w wymagającym otoczeniu bez przygotowania. To *nie jest moralna porażka*, że nadal maskujesz tam, gdzie to **realnie potrzebne**. Niektóre miejsca dożywnotnio pozostaną w trybie maski — i to jest *w porządku*.

Klucz: Maskowanie samo w sobie *nie jest patologią* — to **adaptacja**, dzięki której przetrwałeś/-aś w środowisku, które nie wiedziało o Twoim mózgu. Hinshaw (2018): „*maskowanie jest źródłem zarówno sukcesu, jak i cierpienia osób z ADHD*”. Cel pracy: *nie zrzucić maskę* — tylko **móc ją zdjąć, gdy jesteś sam/-a**. Trzy strefy: *publiczna* (maska niezbędna), *półbezpieczna* (selektywne zdejmowanie), *bezpieczna* (pełna autentyczność). Stopniowo rozszerzaj strefę bezpieczną. To proces lat, nie tygodni.